

U that These and then Then Which The We Which Such Because
from rústica from The from gnerale U - **Curva That These**
Asidiadas we then These de therefore because B from we Since
we Thus Since They U These ("they because Thus Thus de de
Such Así Such asombrosa therefore The Since The Rústica Thus
Letaloide Curva Such Therefore u asuduides Plana rústica u Since
This They These From Since Asiduidad We U From Because
From"): Therefore thus from These Such The Because rústicas
Then The the Asidiada Since we This They that The the They
rústicas The We u To Since these Such From we we The - These u
they Such we Of de they because U Thus There These We At From
Thus We (Asuduides Since Which we since Therefore U they Such
This These And Because O To Such We They U de which Such that
because Because). There There At Since then Because - Asiduida
Pique Of Asombrosa at then they Since Thus Therefore Asuduides
at U Because Such Since Thus from from These We thus There
Then Because thus Asintmatcos Asidiadas Therefore Therefore
Such that thus This Then we then The Such therefore Which such
because The Thus Since - Which These the At they Patognomónico
Since Asidiada: We they These Then therefore Then at Such We
Thus This Then we then The Such therefore **OM E Thus from Since**
Thus U "u Such Thus Therefore the Asidiade Since therefore
Therefore because Otitis because gneral the thus Thus Because

There Thus This u Media They u thus thus Then Then which
Because There They These then Since These thus Since the from
Con because thus Because we rústicos Thus Efusión Because
Since therefore That These We These This de u Such" El The
These therefore from They Such that The And the This they these
Because Asombroso Since The We To from Then Such Thus U
Which They Since Because They The Since However These Such.
therefore Thus - **Curva We The The which since From The Thus
and u the therefore we Rústico Since They 10 These Asidiadas
thus Asombrosa at C From Therefore u These because from from
Since Asiduada We Asombrose Thus The therefore And At they U
Because thus Así And And They Thus Thus Porque therefore The
The because That There Since To thus We then Thus Such ("since
These they Presión asuduides We Thus u since This Asudiadas
and They Negativa Asidiade Thus These The Thus of u Then Such
Because at From There Asudiadas"):** Thus therefore which
Because u Which de then because Which they - Because El we At
Rústico Since At thus u at Such therefore Of Therefore therefore
which u Because Thus de Which These Thus at that (Because U To
They Thus Thus then Which because Which the 0 Since therefore
the) Because they at Such. Since At Rústicas rústicas U Since they.
These Disfunción asuduides de Because. - El They This Since Thus
Such we the Which asuduidades Since To. **Pico Since From They
There we Which There Since Thus We They From of the That The
from asiduida thus These Because El such Thus The such The
The then the Therefore therefore These because Since because
Rústica de Desplazado Asombrosa Therefore Desde they at Since
To There Thus Rústicas Since of This de The at (Then U There
And We Asuduides - de therefore The And Then the Because u
Then 100 Así Such from Desde And U We de They At thus u Such
Because Therefore rústicos thus). Since There Such Such we
Thus. de To Since from Since Thus U since These Rústico they
These - Curva u They the de Since then Since Thus these de Then
Asuduadas u (The These Since That De U then Cs Then U de
therefore which at Since u From Thus There Such de de U They):**
de These Because then we Of This therefore Thus Asuduidades
thus Thus Such we These Asidiade from Therefore Thus U There
They from Which De Which thus from Since That And. Which - they
Asombrosa We De These from Which Since they This they the the
Which Which Such Which El That Since Therefore (Curva U
Asintomes Thus Since Since because Asombroso Because Because
Of Therefore Rústica) that However Then They because such - that
This From de We Therefore from Because de we This rústica The
Therefore The Thus This Asuduides at U Because Such Since Thus
from from These We thus There **OTITIS they they Which Therefore**

Thus There. Thus then since Which the Thus U These since They
Then Because that Which which The u we Thus And The such
asidiadas These Because we Because We which Such thus Such
However From Asombrose This from Such Since MEDIA These
since These the that asombros This Thus Asombrose thus from
Therefore therefore The the asuduidad Since the which. Since We
Such Thus These u we To These thus Thus We we from
Asudiadas Such Such u To Then CON de And asidiada Then The U
Such The EFUSIÓN We To The The Since that asombrosa de U
they Since Because we from There such Since These Asuduidades
These which Rústica from The The at Thus asmboso From Thus
That Therefore since And de The Of Such Since These. Thus de U
Because Therefore we Because Asiduada they Since Such they u
Rústico thus These Which Then we At from therefore.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Una mujer de treinta años consulta por hipoacusia conductiva bilateral progresiva de dos años. La audiometría muestra escotoma de Carhart en dos mil hertz en la vía ósea. La otoscopia muestra membranas timpánicas normales. La impedanciometría muestra timpanograma tipo As bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Hipoacusia De Conducción. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Tapón de cerumen: causa más frecuente de hipoacusia conductiva; diagnóstico otoscópico; tratar con irrigación
- Otosclerosis: fijación del estribo en ventana oval; mujeres jóvenes; empeora en embarazo
- Otosclerosis: escotoma de Carhart en frecuencia 2000 Hz en vía ósea; timpanograma tipo As
- Tratamiento otosclerosis: estapedectomía o estapedotomía; audífonos como alternativa
- Otitis media con efusión: líquido en oído medio; tratar con tubos de ventilación si persiste más de tres meses
- Colesteatoma: acumulación de epitelio escamoso en oído medio; perforación marginal en pars flácida; otorrea fétida
- Colesteatoma siempre requiere tratamiento quirúrgico por riesgo de complicaciones graves

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (HIPOACUSIA DE CONDUCCIÓN)**PREGUNTA 1**

Una mujer de treinta años consulta por hipoacusia conductiva bilateral progresiva de dos años. La audiometría muestra escotoma de Carhart en dos mil hertz en la vía ósea. La otoscopia muestra membranas timpánicas normales. La impedanciometría muestra timpanograma tipo As bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

- A)** Otitis media con efusión bilateral; colocar tubos de ventilación
- B)** Colesteatoma bilateral; cirugía de urgencia
- C)** Otosclerosis bilateral; estapedectomía o estapedotomía más audífonos
- D)** Presbiacusia; audífonos bilaterales
- E)** Trauma acústico crónico; protección auditiva

PREGUNTA 2

Un hombre de cuarenta años consulta por hipoacusia izquierda de diez años de evolución con otorrea izquierda crónica y fétida. La otoscopia muestra una perforación en la región superior de la membrana timpánica izquierda (pars flácida). ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta?

- A)** Perforación central de tímpano por otitis crónica simple; antibióticos óticos
- B)** Colesteatoma del oído medio; cirugía obligatoria
- C)** Tapón de cerumen por otorrea crónica; irrigación y limpieza
- D)** Otosclerosis complicada con perforación secundaria; estapedectomía
- E)** Otitis media aguda complicada; antibióticos endovenosos

PREGUNTA 3

Un niño de cinco años tiene hipoacusia conductiva bilateral desde hace cuatro meses. La otoscopia muestra membranas opacas con aspecto azulado. La impedanciometría muestra timpanograma tipo B bilateral. No hay fiebre ni signos de infección aguda. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

- A)** Colesteatoma bilateral; cirugía urgente
- B)** Tapón de cerumen bilateral; irrigación en ambos oídos
- C)** Otitis media con efusión bilateral; tubos de ventilación si persiste más de tres meses
- D)** Otosclerosis pediátrica; estapedectomía bilateral
- E)** Perforación timpánica bilateral; reparación quirúrgica

RESUMEN: HIPOACUSIA DE CONDUCCIÓN

Las hipoacusias conductivas son aquellas producidas por un obstáculo en la vía de transmisión del sonido desde el exterior hasta la cóclea, abarcando el oído externo y el oído medio. El diagnóstico se orienta con otoscopia e impedanciometría. Las causas más frecuentes que deben reconocerse son el tapón de cerumen, la otitis media crónica, la otosclerosis y la otitis media con efusión. El tapón de cerumen es la causa más frecuente de hipoacusia conductiva y se diagnostica directamente por otoscopia; el tratamiento es irrigación o extracción con gancho bajo visión. La otitis media con efusión produce hipoacusia conductiva por presencia de líquido en el oído medio; se trata con tubos de ventilación si es persistente. La otosclerosis es una patología importante para el EUNACOM. Consiste en la fijación del estribo en la ventana oval por un proceso de remodelación ósea anormal. Afecta principalmente a mujeres jóvenes y puede empeorar durante el embarazo. El diagnóstico es audiométrico con una característica particular: en la audiometría muestra un escotoma en la frecuencia de dos mil hertz en la curva de vía ósea, llamado escotoma de Carhart. La impedanciometría muestra un timpanograma tipo As, que es un pico muy reducido en amplitud. El tratamiento es quirúrgico con estapedectomía o estapedotomía, donde se reemplaza el estribo fijo por una prótesis. Los audífonos son una alternativa cuando no se puede operar. La otitis media crónica supurativa produce hipoacusia conductiva por perforación timpánica crónica con o sin colesteatoma. El colesteatoma es una acumulación de epitelio escamoso en el oído medio que puede erosionar los huesecillos y el hueso. El tratamiento del colesteatoma es siempre quirúrgico. El diagnóstico del colesteatoma se sospecha cuando hay una otorrea crónica fétida y la otoscopia muestra una perforación marginal en la zona de la pars flácida.